

Etablissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS D'URGENCE — ARTICLE R.4311-7 CSP

Surveillance traumatisme crânien

Surveillance neurologique structurée après évaluation initiale rassurante ; elle ne remplace jamais l'indication d'imagerie.

Indications

- Choc crânien ou chute avec impact suspecté.
- GCS à 15 ou état neurologique revenu au niveau habituel.
- Évaluation initiale ne retrouvant pas de critère d'urgence immédiate.
- Surveillance réalisable pendant 24 h avec traçabilité.

Vérifications préalables

- Heure, mécanisme, hauteur, perte de connaissance et amnésie.
- GCS détaillé, pupilles, motricité, céphalée, vomissements et comportement habituel.
- Plaie, hématome, douleur cervicale et autres traumatismes.
- Anticoagulant/antiagrégant, âge, trouble de coagulation ; glycémie si malaise.

Recommandations / IMPORTANT

- Baisse du GCS, déficit, convulsion, vomissements répétés ou céphalée croissante : appel 15.
- Anticoagulant ou trouble de coagulation : avis médical urgent avant toute simple surveillance.
- Ne pas laisser seul ; transmettre le niveau neurologique habituel.
- Une aggravation secondaire reste possible malgré un examen initial rassurant.

Intervention IDE

- Si GCS 15/baseline : toutes les 30 min pendant 2 h, puis chaque heure pendant 4 h.
- Puis toutes les 2 h jusqu'à 24 h, sauf consigne médicale plus stricte.
- À chaque passage : GCS, pupilles, membres, FR, FC, TA, température et SpO2.
- Si détérioration : reprendre toutes les 30 min, appeler le 15 et préparer transfert.

Surveillance et traçabilité

- Tracer chaque observation à l'heure réelle sur une grille dédiée.
- Comparer conscience et comportement au niveau habituel documenté.
- Noter céphalées, nausées/vomissements, sommeil et nouveaux symptômes.
- Transmission orale et écrite à chaque relève.

Alerte immédiate

- Appel 15 : GCS < 15/niveau habituel, anisocorie, déficit, convulsion, vomissements répétés ou somnolence anormale.
- Alerte si douleur cervicale, écoulement clair nez/oreille, aggravation ou nouveau traumatisme.
- Avis médical si surveillance impossible.

Mention de sécurité

La surveillance ne doit pas différer l'imagerie ou l'orientation lorsqu'elles sont indiquées. Tout changement neurologique ou comportemental par rapport à l'état habituel est une aggravation jusqu'à preuve du contraire. Compte rendu IDE écrit, daté et signé au dossier.

Fait à :

Le : / /

Signature et cachet du médecin :